

Zablokowana *żałoba*

Niewypłakana strata bywa źródłem chronicznej depresji, somatyzacji i lęku. Objaw jest powierzchwny — żałoba głębią. Gdy żałoba zostaje przeżyta, objaw często znika.

CZAS: 35 min · poziom zaawansowany Chroniczna depresja; strata „nieprzepracowana”; rocznice

ŹRÓDŁO: Bowlby (1980); Worden (2018)

JAK UŻYWAĆ

Rozpoznajesz sygnały niewypłakanej żałoby (powikłana żałoba, ang. *complicated grief*) i delikatnie reaktywujesz ją w bezpiecznym kontekście. Prowadzisz pacjenta przez cztery zadania Wordena: zaakceptować rzeczywistość straty, przeżyć ból, dostosować się do świata bez zmarłego, znaleźć sposób na zachowanie więzi przy jednoczesnym życiu dalej. Po drodze rekonstruujesz relację i integrujesz ambiwalencję — miłość i gniew, wdzięczność i żal.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Gdy strata (śmierć bliskiego, rozwód, ale też symboliczna — utrata „dobrego rodzica”, dzieciństwa) jest za trudna, zostaje zablokowana i wraca jako chroniczna depresja, somatyzacja czy lęk. Żałoba jest **uniwersalnym mechanizmem** (Bowlby) — próbą ponownego zbliżenia do utraconego obiektu; zablokowana, zatrzymuje się w jednej z faz. STPP pomaga przejść przez wszystkie fazy i uwolnić związaną w stracie energię. Często żałoba *jest* rzeczywistym fokusem, nawet gdy pacjent zgłosił się z „depresją”.

01



Sygnały niewypłakanej żałoby

- chroniczna depresja bez wyraźnej przyczyny
- idealizacja zmarłego
- somatyzacja w okolicy rocznic
- opowieść o stracie bez łez i afektu
- „zatrzymanie w czasie” od momentu straty
- lęk przed bliskością („boję się stracić znów”)

02



Delikatnie zaproś do tematu

„Zauważam, że gdy wspominamy ojca, mówi Pani bez emocji. Czy moglibyśmy pozwolić, żeby uczucia wybrzmiały?” Potem poproś o rekonstrukcję relacji — nie tylko jaki był, ale jaka była ta relacja: co dobrego, co trudnego.

ZABLOKOWANA STRATA I JAK JĄ ZAPROSZĘ

03 ☉ Cztery zadania żałoby (Worden)

- ① zaakceptować rzeczywistość straty
- ② przeżyć ból
- ③ dostosować się do świata bez zmarłego
- ④ zachować więź ze zmarłym i kontynuować życie

Integruj ambiwalencję (patrz osobna karta): pozwól na oba bieguny — miłość i gniew, wdzięczność i żal.

04 ✨ Domknięcie i integracja z życiem

Czasem pomaga rytuał: list, wewnętrzne spotkanie w wyobraźni („gdyby ojciec siedział tu teraz, co chciałaby Pani mu powiedzieć?"), zapalenie świecy. Na końcu: „jak zachować ojca obecnego w Pani życiu, jednocześnie pozwalając sobie żyć dalej?"

FORMA DOMKNIĘCIA DLA TEGO PACJENTA

Klucz: często żałoba jest fokusem STPP, nawet gdy pacjent zgłosił się z „depresją" lub „lękiem". Objaw jest powierzchwnią, żałoba — głębią. Szczególnie w terapii 16-20-sesyjnej domknięcie żałoby bywa pracą centralną; gdy zostaje przeżyta, objaw zwykle ustępuje.